

Fecha Última Actualización: 22-08-2022 5:32:28

Página 1 de 3

Información Paciente

Nombre : Victor Robinson Madrid Campusano
Edad : 69a 1m 26d
Dirección : O Labbe 445

Rut : 6.584.470-2
Fecha Nacto: 27/06/1953
Comuna : Puerto Montt

N° Archivo : 2215382
Sexo : Masculino
Teléfono : 9 1234 5678

N° Epicrisis
319998

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Cirugía Sector B - Mediana Compleji

Fecha Ingreso : 01/08/2022 15:05

Días Estadía: 21

Unidad de Egreso : Upc - Uci Adulto

Fecha Egreso : 22/08/2022 05:08

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

cx vascular

Comorbilidades

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Epidemiología

Resumen Clínico

Nombre: Victor Madrid Campusano
Edad: 69 años
RUT: 6.584.470-2
FI CASR: 01.08.2022
FI UCI: 10.08.2022

Antecedentes:

Médicos: HTA, tabaquismo suspendido

Qx: disección aortica tipo B con TEVAR (2018)

Paciente con antecedentes de Disección aórtica tipo B op TEVAR en 2018. En control de imágenes realizado en mayo del presente año, se evidencia aneurisma toracoabdominal de 8 cm Y AAA infrarenal de 4cm y aneurisma de arteria iliaca común izq de 5 cm. Se hospitaliza en hospital de Iquique para manejo inicial, posteriormente se traslada a CASR para resolución qx por equipo Cx Vascular. Se realiza ev por Cardiología y Anestesia, dando pases operatorios respectivos, programándose Cx debraching para el lunes 08.08.

Ingresa a pabellón dicho día, se instala protesis . pero durante proceso de revascularización visceral se produce desgarro de tronco celiaco en la raíz, no controlable, con hemorragia masiva, aorta supraceliaca se realiza toracotomia anterolateral izquierda control de aorta y clampeo logrando hacer hemostasia de tronco celiaco, ligadura de este y anastomosis a hepatica t-t con prolen 5-0 por desgarro de gastrica izquierda que se clipa. .

Reanimación intraoperatoria:

- 14000ml en Cristaloides,
- 3600 GR (12 Unidades),
- 1000cc de Crioprec (18 Unidades)
- 1300 PFC (6 Unidades)
- 500 de Plaquetas (8 Unidades)

Egres a Recuperación anestésica, en malas condiciones generales con req de NAD a 0.3mcg/kg/min, en espera de cupo UPC. , donde evoluciona al deterioro con requerimientos de epinefrina y presenta evento de PCR presenciado en AESP,

Fecha Epicrisis : 22/08/2022 05:32

Página 1 de 3

Fecha Última Actualización: 22-08-2022 5:32:28

Página 2 de 3

iniciandose RCP saliendo al 4to ciclo.

Con seguimiento de PIA, se evidencia Sd Compartimental del Abdomen, ingresando a pabellón el 09.08, realizándose laparotomía exploradora, donde se evidencia 1000mL de sangrado aprox, se realiza aseo qx y se decide laparotomía contenida., se Tx con 4u GR, egresa, nuevamente a Recuperación, intubado, con aporte de DVA tanto NAD como Epinefrina. En exámenes de laboratorio se observa hiperlactatemia persistente sobre 100mg/dL, falla renal progresiva, falla hepática leve.

El día 10-8-22 Ingresa nuevamente a pabellón para intento de cierre de pared abdominal, se observan asas edematosas, escaso sangrado, se realiza lavado y queda con laparotomía contenida.

Posteriormente ese día se traslada a UCI.

Ingresa UCI en malas condiciones generales, con doble vasoactivo., y febril, se pancultiva y se escala AB a Imipenem, vancomicina,

Se programa HDF la cual fue suspendida por disfunción de cateter y mejoría en lo hemodinámico ya que suspendio adrenalina, continua con Sled

El día 16-8-22 va nuevamente a pabellón a instalación de abbtara ya que no se pudo realizar cierre de pared por edema.

El paciente continua grave con falla renal, hemodinámica, coagulación y hepática

El día 17/8/22 en relación a instalación de cateter femoral derecho por disfunción del previo, se produce un hematoma de zona inguinal, que requirió de transfusión mas aumento de vasoactivos. Se realizan imágenes que evidenciaron una pancreatitis necrohemorrágica mas hematoma retroperitoneal y descartaron isquemia de EEIi

El paciente evoluciona con requerimientos altos de vasoactivos, se mantiene terapia AB empírica y Sled según indicación de nefrología

El día 21-8 paciente con dosis moderadas a altas de vasoactivos, con PCR al alza, se rescata CCAET del 17-8 aislandose una pseudomona ae, pendiente AB grama, en este sentido y dado que lleva 10 días de Imipenem empírico decido escalar a colistín

El paciente en la mañana inicia diálisis con regular tolerancia ya que debio aumentarse levofed y se apoya además con albumina, finaliza diálisis quedando con levofed 0.28 u /k/m, se toman exámenes de control que evidencian aumento de lactato y bicarbonato bajo, por lo cual se volemiza con albumina y se aporta bicarbonato.

Durante la madrugada del 22-8 comienza con aumento de requerimientos vasoactivos, se volemiza y se agrega adrenalina, se realiza ecoscopia via transhepatica evidenciando cava de tamaño adecuado. Se aporta calcio, bicarbonato y albumina sin respuesta, se avisa a familia

Finalmente paciente fallece el 22-8-22 a las

Se avisa a cirugía para retiro de abbtara

Diagnósticos ;

1. Aneurisma toracoabdominoilíaco (toracoabdominal, aorta abdominal infrarrenal y arteria ilíaca común izq).
 - Anastomosis aorto protésica -> Debranching tipo II (08/08/22).
 - Desgarro raíz tronco celíaco, aorta supracelíaca 10 cm, arteria gástrica ligado.
2. Shock hemorrágico + FOM (falla renal, hemodinámica, hepática, respiratoria) en evolución
 - Protocolo transfusión masiva
3. Hematoma femoral derecho sin sangrado activo
4. Pancreatitis necrohemorrágica en evolución
4. PCR AESP ROSC al 4to ciclo.
5. Síndrome compartimental abdomen
 - Laparotomía exploradora 09/08/22 -> Hemoperitoneo sin evidenciar sitio de sangrado -> Bolsa de Bogotá.
 - Cirugía de reexploración 10/08/22 -> edema asas intestinales.
 - Cirugía reexploración 2 16/08/22 -> sin edema intestinal, instalación Abbtara.
6. Insuficiencia respiratoria aguda
- 7- Antecedentes

Dra Lisbona

Diagnóstico de Egreso

Shock hipovolemico -

Fecha Epicrisis : 22/08/2022 05:32

Página 2 de 3

Condición de Egreso Fallecido

Egreso con Catéter Doble J:NO

Fallecido

Plan Post Alta

Indicaciones

Tipo de Reposo :

Régimen Alimentario :

Medicamentos :

Controles

INTERNO

Becado/Residente



Maria L. Lisbona Torres
Médico Tratante (Staff)